Marketplace de salud

Avance de fase dos

MiDoc centraliza el expediente bajo control del paciente y ofrece a profesionales y centros médicos búsqueda, agenda y seguimiento. La nube permite compartir los servicios entre ubicaciones y mantener la persistencia sin un servidor local permanente.

Repositorio: github.com/EmmanuelPulidoTinajero/MiDoc

> **Video:** pendiente por indicación del usuario. Este PDF es un borrador; no acredita una entrega final completa.

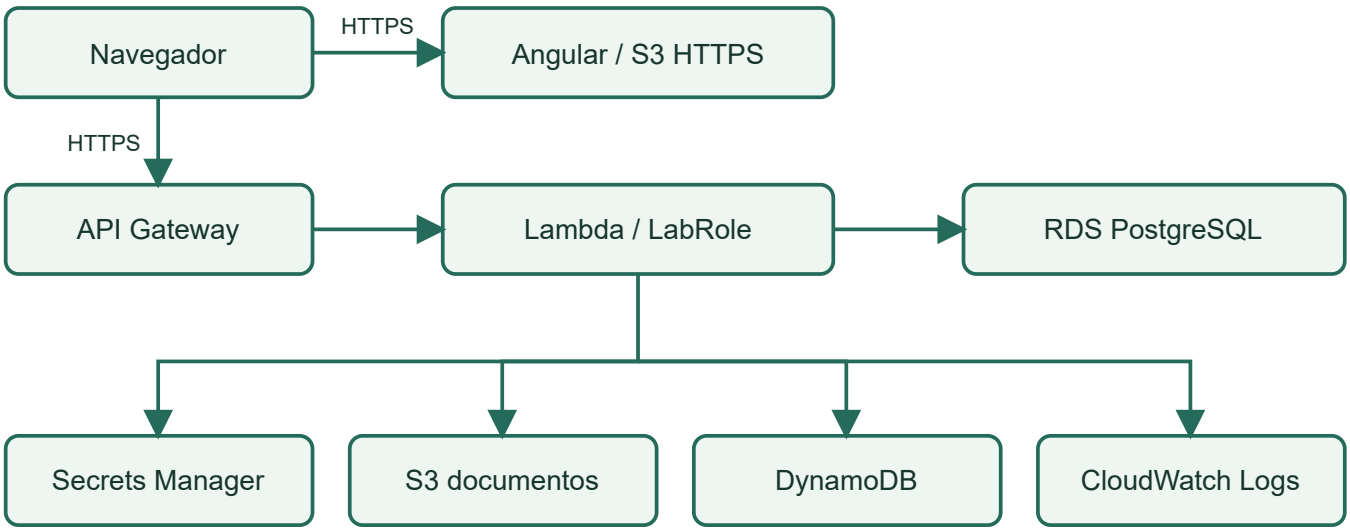
Flujo que se demostrará	Entrada, lógica y resultado	Evidencia disponible
1. Búsqueda y agenda	Filtrar por especialidad/ubicación, revisar perfil/disponibilidad, reservar; confirmar, cancelar o reprogramar con validación de horario.	API y navegador Edge verificados; video pendiente.
2. Expediente y consentimiento	Paciente actualiza expediente y autoriza/revoca acceso. Profesional requiere suscripción y consentimiento; documentos privados usan URLs firmadas S3.	Persistencia, acceso y ciclo de archivo sintético probados en AWS.
3. Suscripción y consulta	Suscripción demo de $20 USD/30 días; consulta de cita iniciada registra diagnóstico, tratamiento y receta en historial.	Consulta en RDS y receta desde Edge verificadas. Pago simulado.

Alcance adicional del Reporte 1

Incluye historial, recetas imprimibles, inventario, promociones, mensajes y avisos internos. EventBridge genera recordatorios cada 15 minutos sin navegador; sin correo/push.

Los consultorios, clínicas y hospitales comparten el rol CLINICA de Tarea 2. Pacientes se registran gratis. Todas las pruebas usan datos sintéticos.

Arquitectura implementada



Servicio	Uso y decisión
Lambda + API Gateway	API Python 3.12 dentro de VPC, expuesta por HTTPS con JWT y validación por rol.
RDS PostgreSQL	Fuente relacional: usuarios, citas, consentimiento, expediente, consultas/recetas y ampliaciones. Instancia privada y cifrada.
Secrets Manager	Llave JWT y credenciales RDS. Tarea 2 sustituye Cognito por autenticación propia debido a la restricción documentada de User Pools.
S3	Web estática separada de documentos privados. POST/GET firmados por 300 segundos para archivos clínicos sintéticos.
DynamoDB	Bitácora complementaria de accesos; no sustituye relaciones/transacciones de PostgreSQL.
EventBridge	Invoca Lambda cada 15 minutos para generar recordatorios y vencimientos sin navegador ni roles nuevos.
IAM / CloudWatch	Usa LabRole existente; no crea IAM roles/policies. Logs Lambda disponibles; monitoreo de negocio pendiente.

Red: Lambda usa endpoints VPC para Secrets Manager, S3 y DynamoDB; RDS acepta conexiones del security group de Lambda.

Decisiones, estado y evidencia

Componente	Estado
Frontend	Desplegado en endpoint REST S3 HTTPS con /index.html, sin CloudFront.
Backend y datos	Lambda/API Gateway, RDS, Secrets Manager, DynamoDB y documentos S3 funcionan en AWS.
Equipo local	Editor, compilación, pruebas y Terraform locales; correcciones desplegadas en AWS. Git sin commit/push.
CI	Pruebas backend, build Angular y validate Terraform. Node 24 requerido por Angular 22. CD no configurado.

URLs de evidencia:
API: 4otc5sejki.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/health
Frontend HTTPS: midoc-frontend-647018795197.s3.us-east-1.amazonaws.com/index.html

- Verificación real: API ok, web 200; Lambda Active/Successful; RDS 16.13 available, privado y cifrado.
- 36 pruebas locales aprobadas: negocio y regresiones de adaptadores HTTP, configuración y login. Build Angular y Terraform fmt/validate aprobados.
- Tres flujos AWS: 43 peticiones verificadas más consulta/receta desde Edge; citas, expediente, S3, inventario, promociones y mensajes.
- Edge: seis recorridos, ocho vistas axe sin infracciones detectadas, anchos 320/390px. Falta auditoría asistiva manual.

Correcciones desplegadas

Evitar duplicados de suscripción semilla; serializar inicialización; exigir configuración RDS y Secrets Manager en producción; TLS obligatorio en el cliente PostgreSQL; soportar DELETE/JSON inválido; alinear Node CI; mejorar carga DICOM y vistas de documentos; script seguro para publicar frontend sin recrear bucket.

Consistencia: negocio y avisos comparten transacción; regresiones comprueban rollback ante fallo. Falta idempotencia del cliente ante pérdida de respuesta. EventBridge genera recordatorios cada 15 minutos y su ejecución automática se verificó en CloudWatch.

Cierre de fase dos

Los componentes centrales están en AWS. No se afirma un porcentaje funcional exacto sin una matriz de aceptación y demo. Se conservan como pendientes explícitos:

1. Video parcial de máximo 10 minutos, pendiente por indicación del usuario.
2. Correo/push y pagos reales no implementados; mantener simulaciones explícitas.
3. Revisar/publicar cambios locales y alinear el código mostrado en GitHub con el despliegue.
4. Formalizar migraciones PostgreSQL, idempotencia del cliente y pruebas de recuperación/concurrencia.
5. Completar revisión manual con lector de pantalla, foco y zoom; axe no certifica conformidad WCAG.

Permisos: evidencia acotada

Se denegaron ListDistributions/GetDistribution de CloudFront y GetAccount/ListEmailIdentities de SES. Esto no prueba que crear una distribución o enviar correo estén prohibidos. SNS sólo mostró RedshiftSNS y no se reutilizó. Correo no implementado; scheduler EventBridge desplegado sin roles nuevos.

Simulaciones y próximos hitos

La suscripción valida una tarjeta de prueba y asigna vigencia; no cobra. Las promociones no aplican cargos automáticamente. Recordatorios automáticos en AWS; la bandeja se consulta al abrir MiDoc. CI/CD completo se prepara para la sesión del 12 de noviembre; cinco métricas, dos alertas y dashboard quedan para la fase final del Proyecto Integrador.

Integrante	Rol del Reporte 1
Emmanuel Pulido Tinajero	DevOps, infraestructura y soporte frontend/backend
David (Dakewer)	Frontend de pacientes y profesionales
Gilberto Anaya	Backend, expediente y lógica de negocio

El historial Git contiene participación de los tres integrantes. Los cambios nuevos siguen pendientes de commit/revisión.

Fuentes de alcance: Reporte de fase 1 (pp. 1–2), Tarea 2 (pp. 1–6), Proyecto Integrador (p. 4 para fase dos y pp. 5–6 para hitos posteriores). Ver `docs/REVISION-INTEGRAL.md` para hallazgos y evidencia detallada.